

Werkagenda D5 AZWA - puntsgewijze samenvatting

Wat moet er in de regionale werkagenda komen?

Bron: Opdracht voor de werkagenda - Samenwerking zorg en sociaal domein voor D5 AZWA, versie 20 april 2026. Deze samenvatting is bedoeld als leesbare checklist naast het originele document.

1. Overkoepelende regionale doelen

- Concrete gezondheidsdoelen voor de regio.
- Concrete welzijnsdoelen voor de regio.
- Aansluiting op bestaande doelen uit het regioplan.
- Onderbouwing vanuit regionale opgaven, populatiekenmerken, regioscan, rode-dradenanalyse en eventueel GGD-advies.
- Duidelijk onderscheid tussen doelen gericht op minder zorggebruik en doelen gericht op betere gezondheid en welzijn.

2. Prioritering en fasering

- Welke basisfunctionaliteiten eerst worden opgebouwd of opgeschaald.
- Waarom die volgorde gekozen wordt.
- Hoe de regio toewerkt naar regionaal dekkend aanbod in 2030.
- Per basisfunctionaliteit: huidige situatie, gewenste eindsituatie, ingroeipad, aantallen/capaciteit en tempo van opschaling.
- Motivatie als de regio afwijkt van landelijke streefwaarden.

3. Financiële dekking

- Per basisfunctionaliteit: hoe de financiering wordt geregeld.
- Verdeling tussen gemeentelijke middelen, zorgverzekeraar/Zvw, AZWA-middelen en eventuele doorbraakmiddelen sociaal domein.
- Afspraken over structurele borging richting 2030.
- Aandacht voor onderdelen waar financiering nog onzeker is, zoals sommige nieuwe rollen of aanpakken.

4. Verantwoordelijkheid en governance

- Wie doet wat: mandaatgemeente, preferente zorgverzekeraar, gemeenten, GGD, zorgaanbieders, welzijnsaanbieders, huisartsen/eerstelijns, ziekenhuizen/tweede lijn en samenwerkingsverbanden zoals RHO's, RESV's, MGN en VSV's.
- Afspraken over regionale en lokale schaal: wat wordt regionaal geregeld en wat wordt lokaal uitgevoerd.
- Afspraken over besluitvorming binnen de IZA-governance.
- Afspraken over vaststelling door alle colleges van B&W.;
- Afspraken over aanspreekbaarheid: wat gebeurt er als partijen hun afspraken onvoldoende uitvoeren.

5. Netwerksamenwerking

- Welke partijen elkaar nodig hebben per basisfunctionaliteit.
- Hoe verwijzing, toeleiding en terugkoppeling verlopen.
- Hoe partners elkaar weten te vinden.
- Hoe aanbod vindbaar wordt gemaakt, ook voor de tweede lijn.
- Afspraken over gegevensdeling, privacy, casuïstiekbespreking, inwonersperspectief en samenwerking tussen zorg, sociaal domein, publieke gezondheid en informele steun.

6. Lerende cyclus, monitoring en evaluatie

- Hoe de regio de uitvoering volgt.
- Hoe de regio leert en bijstuurt.
- Welke overlegstructuur hiervoor wordt gebruikt.
- Hoe resultaten en effecten worden geevalueerd.
- Hoe wordt aangesloten op de landelijke monitoring/dataset zodra die beschikbaar komt.
- Hoe de regioscan opnieuw wordt benut bij herhaling eind 2027 en eind 2028.

7. Basisfunctionaliteiten die verplicht moeten terugkomen

- Laagdrempelige steunpunten: minimaal een steunpunt per gemeente; passend netwerk van steunpunten; aandacht voor EPA-doelgroep en sociaal-emotionele kwetsbaarheid.
- Sociaal verwijzen: capaciteit bij huisartsen/eerstelijns voor signalering; brugfunctionaris vanuit sociaal domein; brede vraagverheldering; toeleiding naar passende ondersteuning.
- Valpreventie: opsporen van 65-plussers met verhoogd valrisico; valrisico-inschatting; erkende valpreventieve beweeginterventies; structureel beweegaanbod voor ouderen.
- Ketenaanpak overgewicht en obesitas volwassenen: centrale zorgcoördinator; beweegaanbod; aanbod gezondheidsvaardigheden/leefstijl; individuele ondersteuning; GLI; afspraken over signalering door zorg en sociaal domein.
- Kansrijke Start: lokale en regionale coalities; aanbod voor kwetsbare ouders in de eerste 1000 dagen; samenwerkingsafspraken op uitvoerend, organisatorisch en bestuurlijk niveau; betrokkenheid van ervaringskennis en ouders.
- Integrale gezinspoli: kernteam medisch, publieke gezondheid en sociaal domein; een aanspreekpunt voor gezinnen; MDO; werkproces voor gezinnen die dreigen in te stromen in tweedelijnszorg; afspraken over taakverschuiving.
- Nu Niet Zwanger: structurele regionale coördinatie, minimaal 2 fte per regio verdeeld over 3 personen; kinderwensverkenning in reguliere werkwijzen; samenwerking met ziekenhuizen, verloskundigen en huisartsen; toegankelijke anticonceptiezorg; afspraken over schaal: GGD-regio versus IZA-regio.

8. Lopende ontwikkelagenda 1

- Mentale gezondheidsnetwerken: uitvoering van het regiospecifieke MGN-transformatieplan; borging na afloop van het transformatieplan; verbinding met sociaal verwijzen en laagdrempelige steunpunten.
- Ketenaanpak overgewicht en obesitas kinderen: centrale zorgverlener; kinder-GLI-aanbieder; regionale coördinatie; afspraken over wat door zorgverzekeraar en wat door gemeente wordt ingekocht.

9. Nieuwe ontwikkelagenda 1: alleen indien de regio wil beproeven

- Opnemen als de regio met een of meer van deze aanpakken wil starten: dementie, nicotinevrij, rookvrije start, multiproblematiek in NPLV-gebieden.
- Dan moet de werkagenda bevatten: toezegging om met de aanpak aan de slag te gaan, onderbouwing vanuit regionale opgaven en populatie, en rol van de regio als beproevende regio.

10. Ontwikkelagenda 2 en overige initiatieven

- Deze hoeven niet verplicht in de werkagenda.
- Ze mogen wel worden opgenomen als dat regionaal praktisch is.
- Voor deze aanpakken is geen landelijke financiering beschikbaar.
- Alleen opnemen wanneer ze logisch aansluiten bij de regionale zorg-sociaal-domeinagenda.

11. Samenhang tussen basisfunctionaliteiten

- Opsporing en signalering organiseren vanuit leefgebieden, niet per afzonderlijke basisfunctionaliteit.
- Overlap tussen doelgroepen expliciet maken.
- Koppeling tussen mentale gezondheid, leefstijl, ouderen, kansrijk opgroeien en sociaal verwijzen organiseren.
- Voorkomen dat inwoners via parallelle routes langs elkaar heen worden geholpen.
- Zorgen dat professionals weten waar aanbod beschikbaar is.

12. Proces en mijlpalen

- Eind mei 2026: handreikingen basisfunctionaliteiten beschikbaar.
- Eind mei 2026: duidelijkheid proces beproevende regio's.
- Medio juli 2026: RESV-plannen indienen bij zorgverzekeraar.
- Half september 2026: werkagenda klaar aan de IZA-tafel en richting colleges.
- 15 november 2026: regionale werkagenda vastgesteld en verstuurd naar VWS.
- December 2026: duidelijkheid over ontwikkelagenda deel 2.
- 1 januari 2027: start uitvoering werkagenda.
- Praktisch aandachtspunt: hoewel de formele deadline 15 november is, moet de werkagenda door de benodigde collegevaststelling feitelijk half september gereed zijn.

Kernboodschap: de werkagenda verbindt doelen, prioriteiten, financiering en verantwoordelijkheden tot een gezamenlijke regionale uitvoeringsagenda voor zorg en sociaal domein.